

精密儀器檢查 (Precision instrument inspection)

頸動脈超音波檢查

報告
診斷 (Diagnosis) 頸動脈：兩側頸動脈球狀部有輕度粥狀硬化斑塊但不影響血液流動 椎動脈：右側椎動脈血流偏低，但兩側椎動脈加總血流量足夠

精密儀器檢查 (Precision instrument inspection)

甲狀腺超音波檢查

報告
診斷 (Diagnosis) 甲狀腺腫大 左側甲狀腺結節 0.6 公分

精密儀器檢查 (Precision instrument inspection)

心臟超音波檢查

報告
診斷 (Diagnosis) 左心房及左心室大小正常 左心室收縮功能正常(LVEF=52.5%) 無局部左心室壁活動異常

精密儀器檢查 (Precision instrument inspection)

攝護腺超音波

報告
診斷 (Diagnosis) 無明顯異常

精密儀器檢查 (Precision instrument inspection)

肝纖維化掃描

報告
診斷 (Diagnosis) 肝纖維化等級：輕度至中度 脂肪肝等級：重度

超音波影像



恩主公醫院

神經科頸動脈超音波檢查報告

病患姓名: _____	性別: M	檢查日期: 20211021
病歷號碼: I _____	病患來源: _____	檢查時間: 120958
年齡: 49	病床號碼: _____	編號: PEH0610A206002

頸動脈超音波檢查

Right

Intima 0.57 mm

CCA Normal

BULB < 15% stenosis

ICA Normal

ECA Normal

VA Normal



Left

Intima 0.67 mm

CCA Normal

BULB < 15% stenosis

ICA Normal

ECA Normal

VA Normal



Flow Pattern 頸動脈生圖檢查

	PSV	EDV	RI
CCA	72.8 cm/sec	31.2 cm/sec	0.57
ICA	43.8 cm/sec	21.5 cm/sec	0.51
ECA	52.7 cm/sec	11.9 cm/sec	0.77
VA	33 cm/sec	14.3 cm/sec	0.57

Right

CCA Normal

ICA Normal

ECA Normal

VA Normal

Left

CCA Normal

ICA Normal

ECA Normal

VA Normal

Flow Volume RVA 43 + LVA 107 = 150

Result: Abnormal

Conclusion:

The duplex showed mild plaques over bilateral bulbs without hemodynamic change. The total VA flow amount was adequate, though low flow over right VA.

Checker: 劉顯達醫師

超 音 波 影 像



恩主公醫院

成人心臟超音波檢查報告

病患姓名:	性別: M	檢查日期: 20211021
病歷號碼:	病患來源:	檢查時間: 114050
年 齡: 49	病床號碼:	編號: PEH0510A206002

[M-mode]

	測量值	單位
IVSd	0.8	cm
LVIDd	4.91	cm
LVPWd	1.02	cm
LVIDs	3.39	cm
Ao root diam	2.88	cm
LA dimension	3.72	cm
LA/AO	1.29	
EF(Teich)	52.5	%
EPSS	0.71	cm
AVE	1.77	

[Ao flow]

	測量值	單位
Ao V max	60.16	cm / s
Ao max PG	1.45	mmHg

[Mitral flow]

	測量值	單位
MV E point	62.4	cm / s
MV A point	57.9	cm / s
MV E/A	1.08	
MV max PG	1.6	mmHg

[PA flow]

	測量值	單位
PA V max	52	cm / s
PA max PG	1.1	mmHg

[Tricuspid flow]

	測量值	單位
Max vel(TR)	170.8	cm / s
Max PG(TR)	11.7	mmHg

[Conclusion]

Normal LA and LV size, fair LV contractility, LVEF = 52.5%.
No LV regional wall motion abnormality

Checker: 劉顯達醫師

超音波影像



恩主公醫院

Shear wave 肝纖維化及脂肪肝掃描

病患姓名:	性別: M	檢查日期: 20211021
病歷號碼:	病患來源:	檢查時間: 092613
年齡: 49	病床號碼:	編號: PEH1610A206002

肝硬度數值 (Liver Stiffness)SWM(shear wave measurement) = 1.45

參考範圍:

纖維化等級	SWM Cut-off 值 (m/s)
正常 (F0)	≤ 1.19
輕度 (F1)	1.30
中度 (F2)	1.47
重度 (F3)	1.81
肝硬化 (F4)	≥ 2.00

註：SWM 為多次掃描後數值的平均值，因為非侵入性檢查，其診斷率會受部份因素影響(如脂肪肝、呼吸配合度、是否曾開刀、腸氣多寡...等)，判讀結果僅供臨床醫師參考，最終仍需配合臨床醫師判斷是否需要其他輔助性檢查(如血液檢查、病理切片、影像檢查)。

脂肪肝數值 ATT (attenuation coefficient) = 0.91

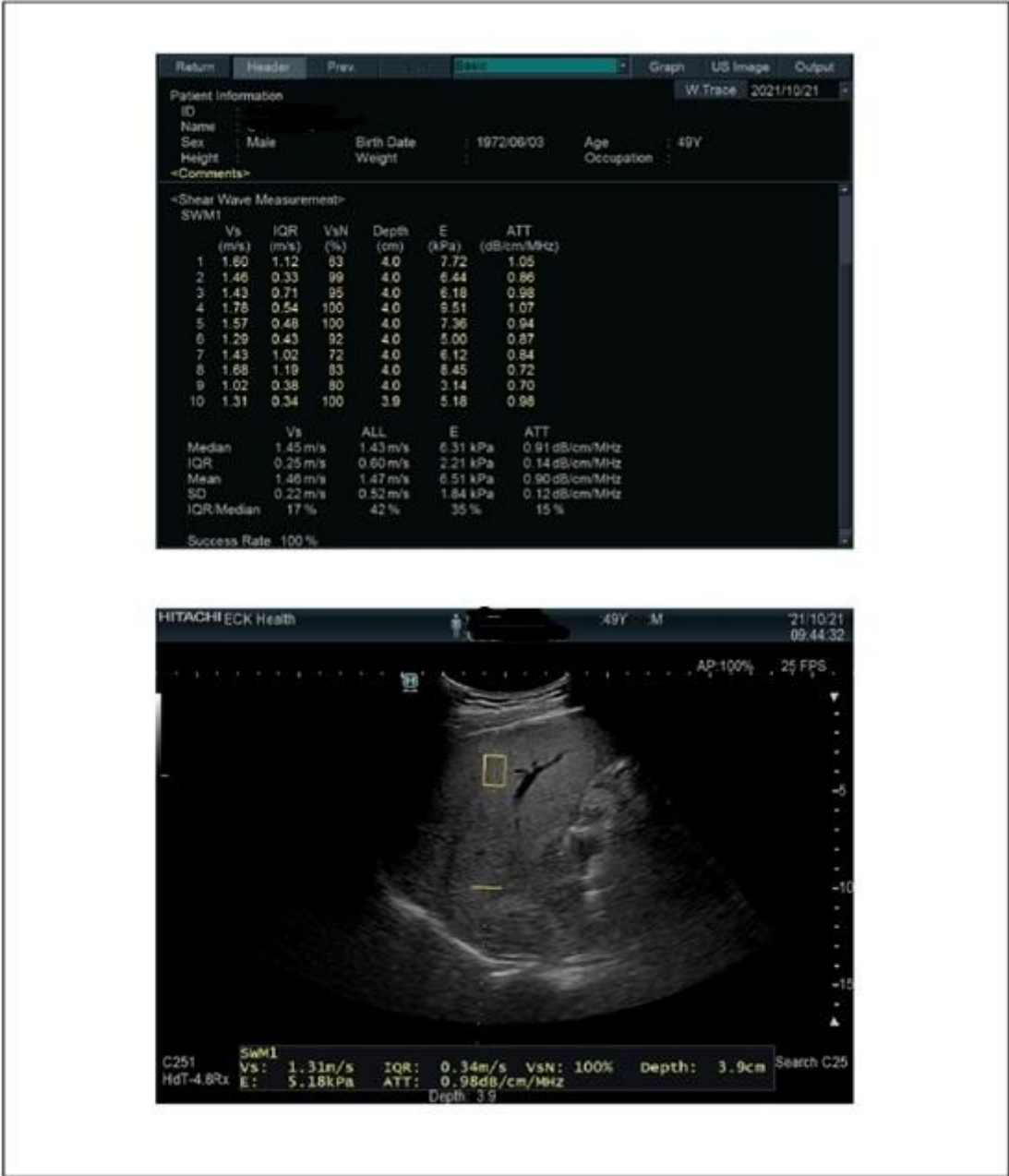
參考範圍:

脂肪肝等級	ATT 值 (dB/cm/MHZ)
正常 (S0)	≤ 0.61
輕度 (S1)	0.62-0.66
中度 (S2)	0.67-0.72
重度 (S3)	≥ 0.73

註：若受檢者的皮下脂肪太厚，有可能影響數值準確度。若ATT數值跟實際影像狀況有落差時，應由醫師評估實際超音波狀況，來判定脂肪肝程度。

Checker: 劉顯達醫師

超声波影像



HITACHI ECK Health

49Y .M

21/10/21
09:44:32

AP:100% 25 FPS

C251

HdT-4.8Rx

SWM1

Vs: 1.31m/s

IQR: 0.34m/s

VsN: 100%

Depth: 3.9cm

E: 5.18kPa

ATT: 0.98dB/cm/MHz

Depth: 3.9

Search C25

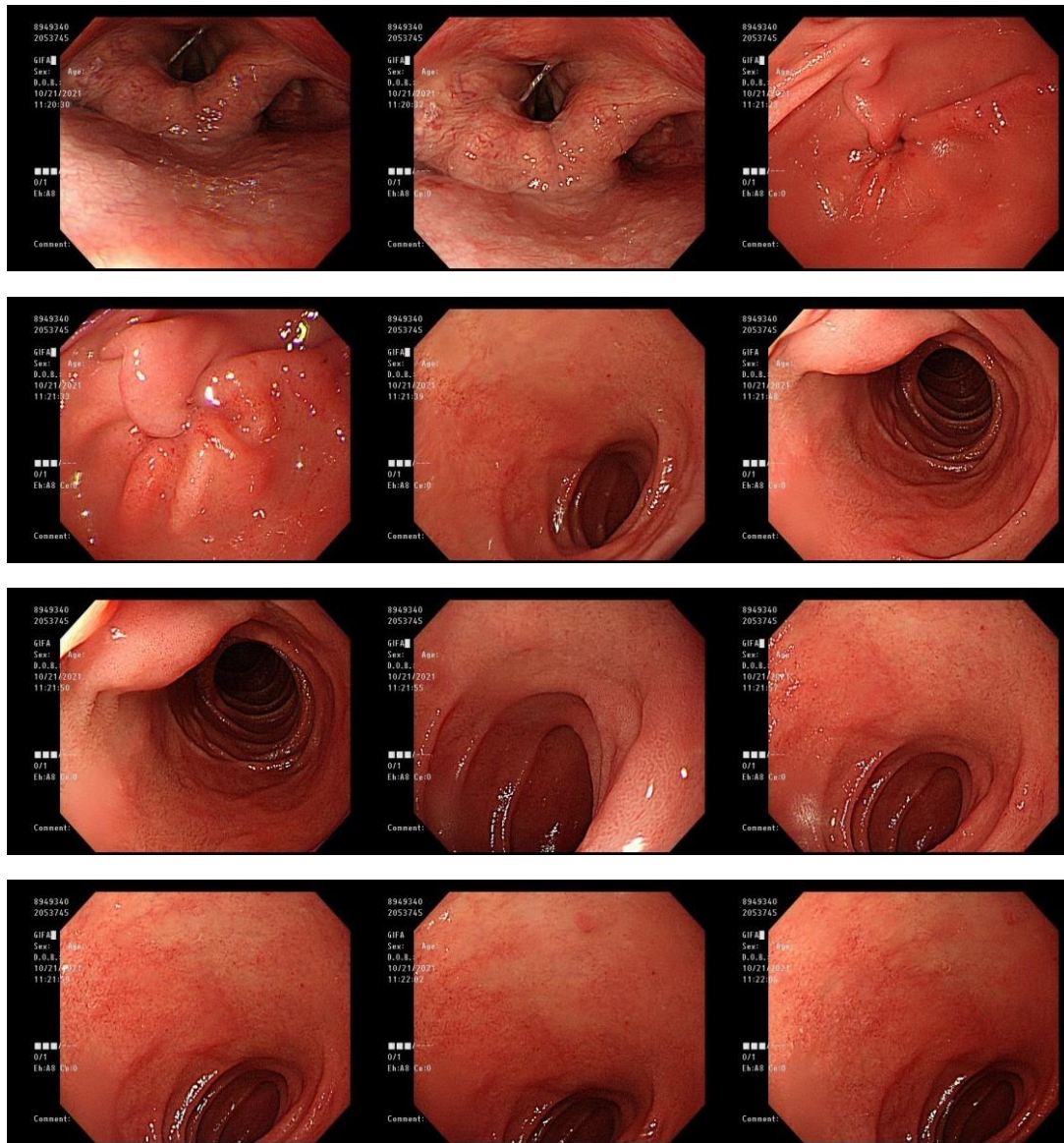
內視鏡檢查

精密儀器檢查 (**Precision instrument inspection**)

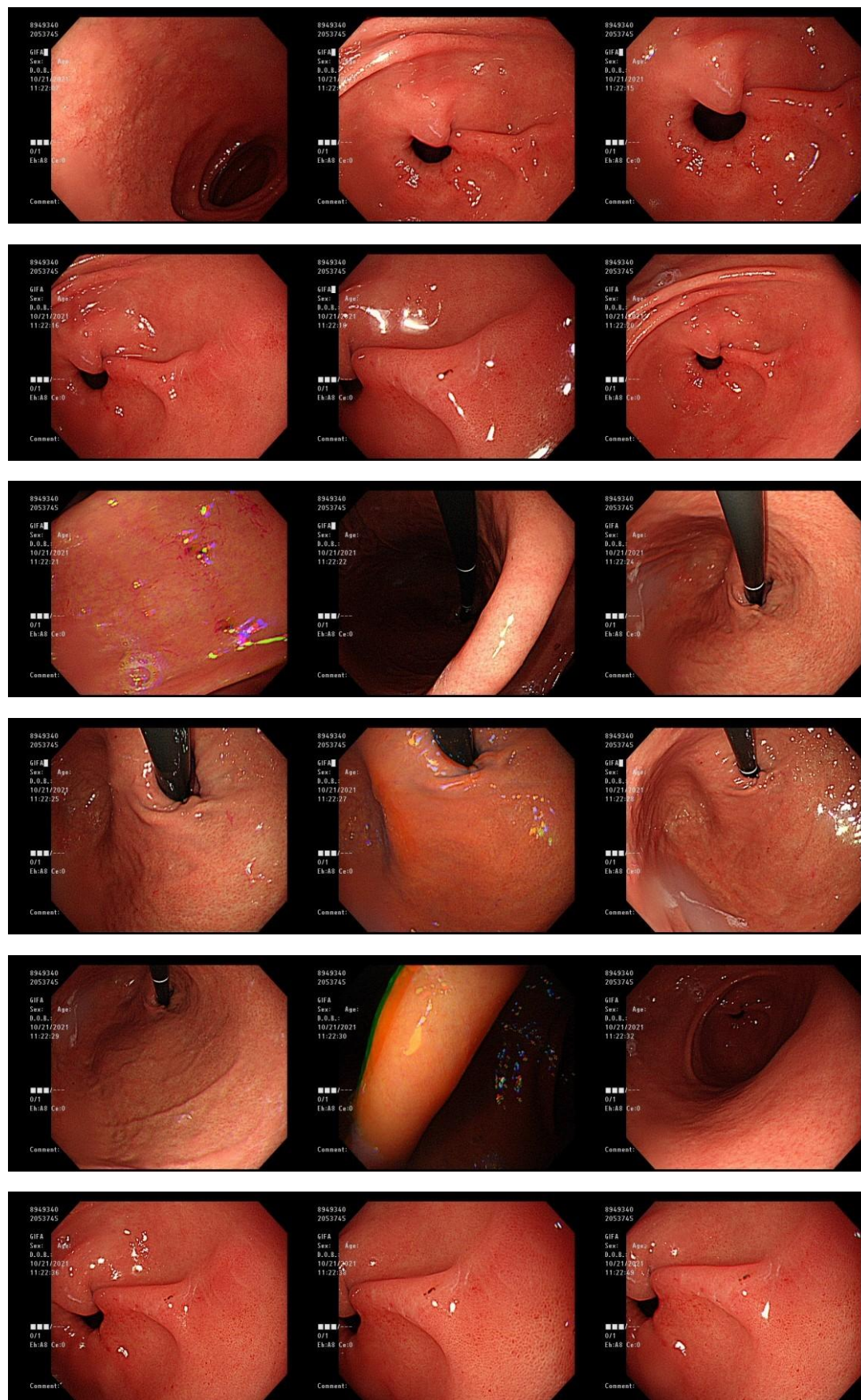
胃鏡

報告
診斷 (Diagnosis) 逆流性食道炎(LA class A) 胃竇處表淺性胃炎及潰瘍，已切片，病理報告為慢性發炎

內視鏡影像



內視鏡影像



內視鏡影像



精密儀器檢查（Precision instrument inspection）

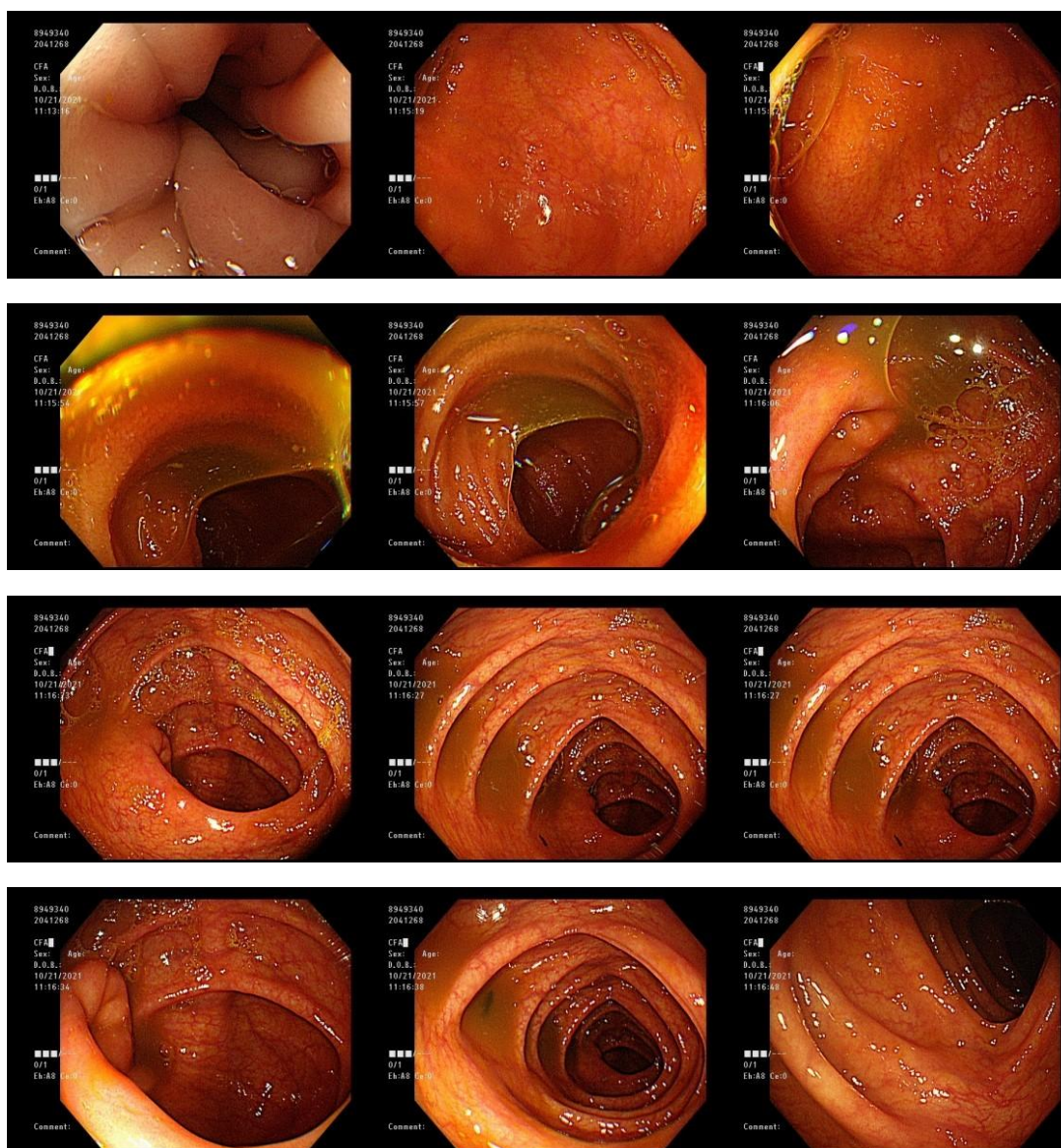
大腸鏡

報告

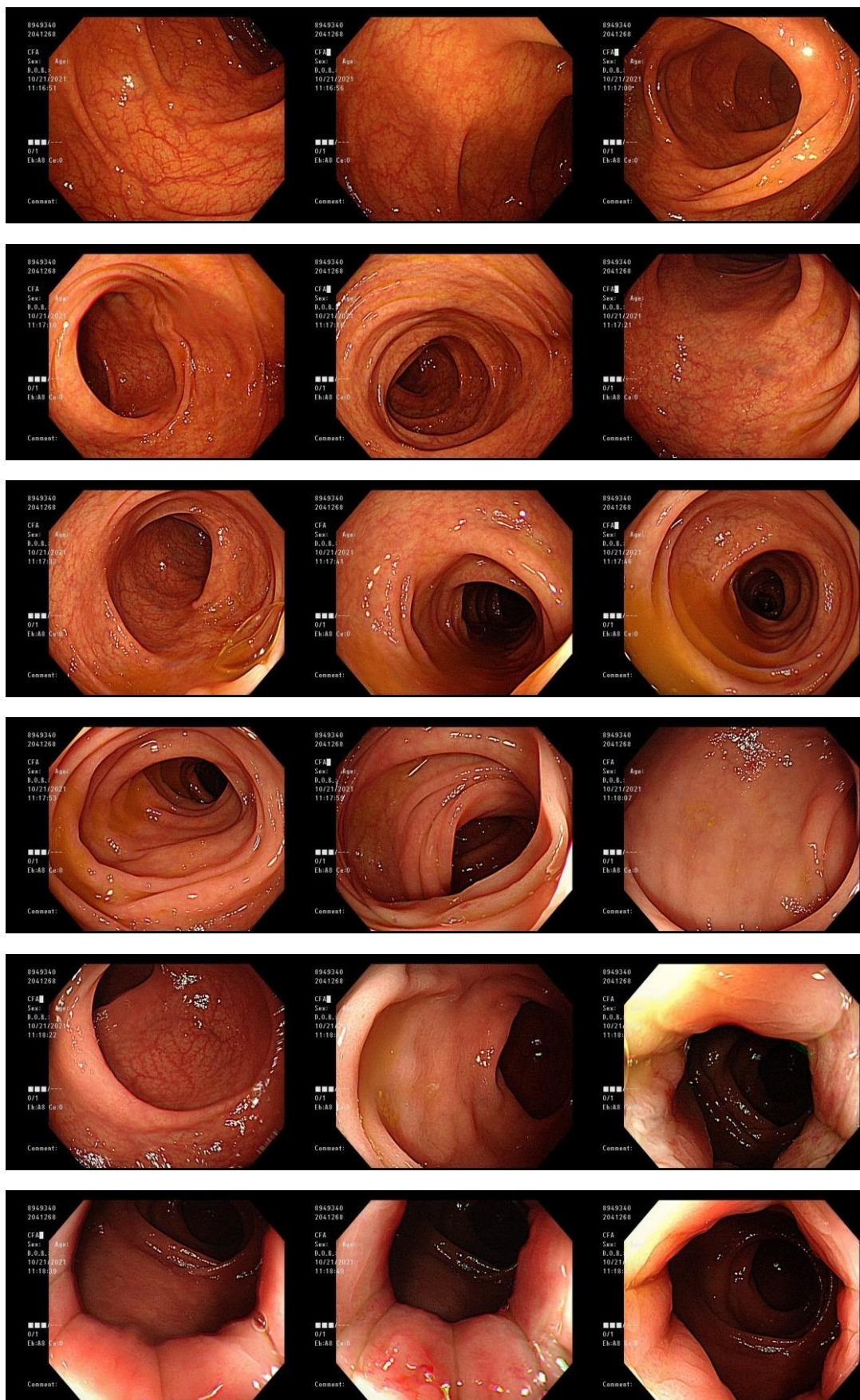
診斷（Diagnosis）

內痔及外痔

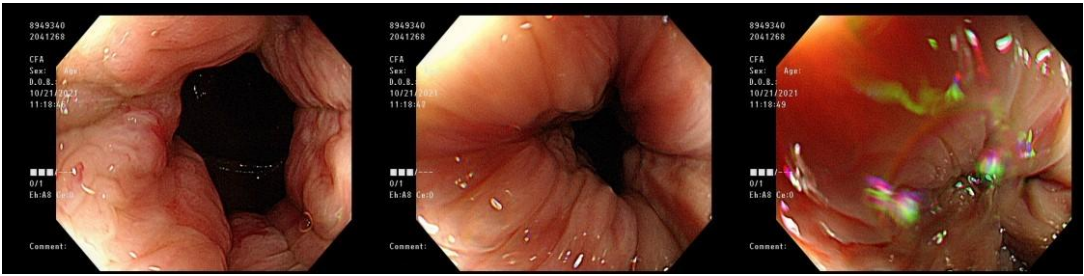
內視鏡影像



內視鏡影像



內視鏡影像



精密儀器檢查（Precision instrument inspection）

胸部 X 光檢查

報告
診斷（ Diagnosis ） 陳舊性肋骨骨折

精密儀器檢查（Precision instrument inspection）

骨質密度檢查(三部位)

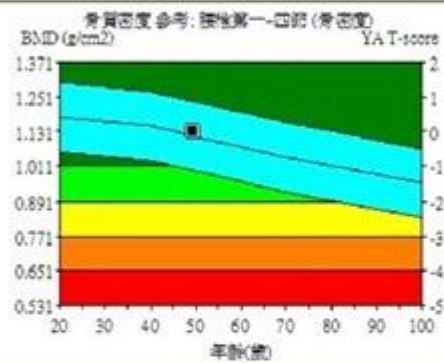
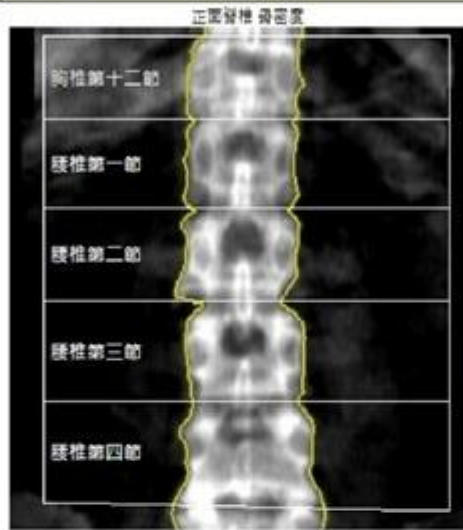
報告
診斷（ Diagnosis ） 骨質密度正常，測量部位：腰椎第一二三四節

骨質密度影像

骨質密度影像

行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院
骨質密度報告

受檢者:	病歷號:
生日: 1972/6/ 49.3 歲	檢測ID: X10AK6010
身高 / 體重: 170.0 cm 72.0 kg	測量: 2021/10/21 上午 (13.60)
性別 / 種族: 男性	分析: 2021/10/21 上午 (13.60)



區域	骨密度 ¹ (g/cm ²)	年輕的成年人 ² T-score	與同年齡正常人群 ³ Z-score
腰椎第一節	0.983	-0.7	-0.6
腰椎第二節	1.150	0.1	0.2
腰椎第三節	1.156	0.0	0.1
腰椎第四節	1.208	0.6	0.5
腰椎第一~四節	1.133	0.0	0.1

影像不用作診斷

列印: 2021/10/21 上午 09:36:14 (13.60) 761.5022.2427.0.0009.06.0.60x1.05

20.7% 雜訊 = 37.9%

0.000.00.0.000.0.00

檔案名: 5wza1r55e5.dfx

掃描模式: 標準一前側位三節位 42.0 µGy

1. 在統計上68%的數據應落在1個標準差內。(±0.021 g/cm² for 正面腰椎 腰椎第一~四節)

2. 亞洲 (年齡20-40) 正面腰椎 參考人數 (n=111)

3. 參考值: 體重(男性 25-100 kg), 體重比較校正

11. WHO世界衛生組織 - 對於高加索白種人骨質密度以及體重量的判定標準為: 正常=T-score ≥ -1.0 SD; 低骨量=T-score 介於 -1.0 ~ -2.5 SD; 骨質疏松症=T-score ≤ -2.5 SD; (WHO世界衛生組織的判定標準只有在T-score判定是參照年輕健康的高加索白種人參考數據時適用。)

骨質密度影像

行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院
骨質密度報告

受檢者:		病歷號:	
生日:	1972/6/ 49.3 歲	檢測ID:	X10AK6010
身高 / 體重:	170.0 cm 72.0 kg	測量:	2021/10/21 上午 (13.60)
性別 / 種族:	男性	分析:	2021/10/21 上午 (13.60)

附屬結果 [正面脊椎]

區域	骨密度 ¹ (g/cm ²)	年輕的成年人 ² (%) T-score		與同年齡正常人群 ³ (%) Z-score		骨礦鹽含量 (g)	面積 (cm ²)	寬度 (cm)	厚度 (cm)
胸椎第十二節	1.155	-	-	-	-	15.28	13.23	4.2	3.15
腰椎第一節	0.983	92	-0.7	93	-0.6	13.84	14.08	4.2	3.36
腰椎第二節	1.150	101	0.1	102	0.2	17.46	15.18	4.2	3.57
腰椎第三節	1.156	101	0.0	101	0.1	18.81	16.28	4.3	3.81
腰椎第四節	1.208	106	0.6	106	0.5	23.99	19.85	5.0	4.01
腰椎第一~二節	1.070	98	-0.2	99	-0.1	31.30	29.26	4.2	6.93
腰椎第一~三節	1.100	99	-0.1	100	0.0	50.11	45.54	4.2	10.75
腰椎第一~四節	1.133	100	0.0	101	0.1	74.10	65.39	4.4	14.76
腰椎第二~三節	1.153	101	0.1	102	0.2	36.27	31.46	4.3	7.39
腰椎第二~四節	1.175	103	0.2	103	0.3	60.26	51.31	4.5	11.39
腰椎第三~四節	1.185	103	0.3	104	0.3	42.80	36.12	4.6	7.82

1-在絕對上68%的骨礦鹽應將在1個標準差內。 (+/-0.001 g/cm² for 正常脊椎 腰椎第一~四節)

2-亞洲 (年齡20-40) 正常骨質參考人數 (n=111)

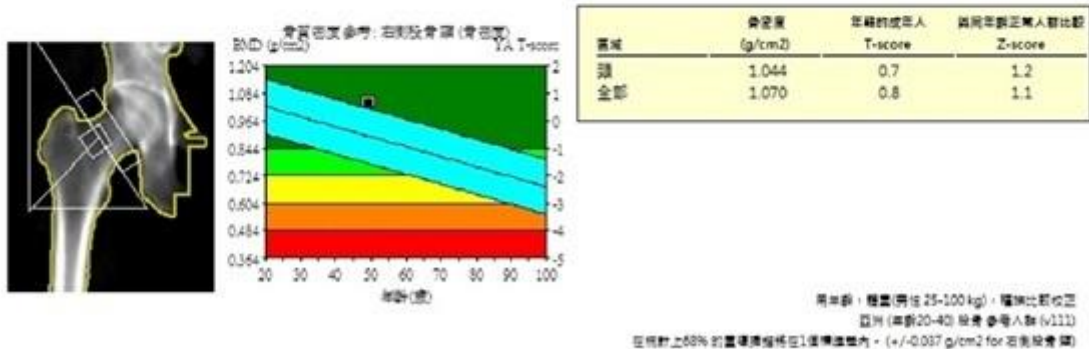
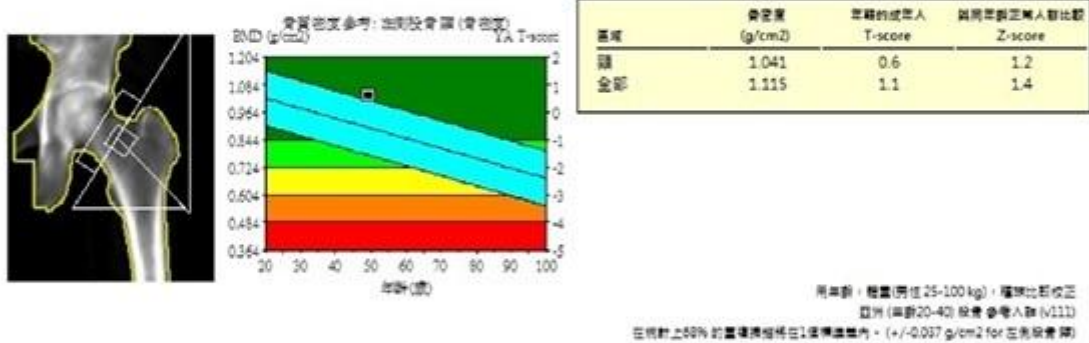
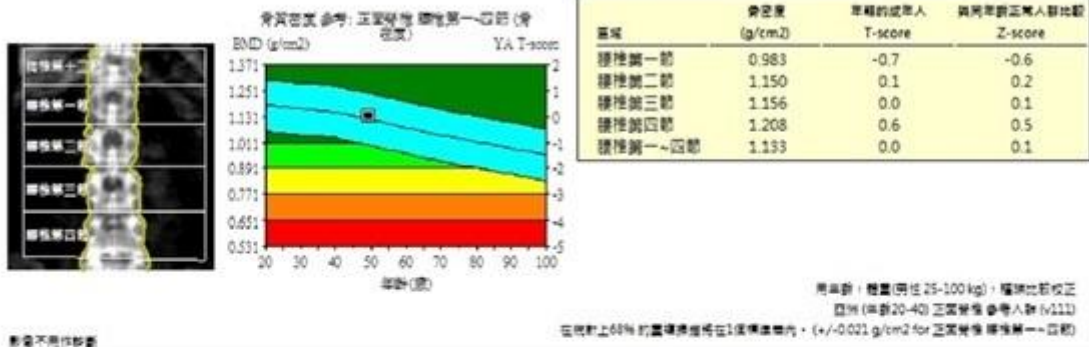
3-用年齡、體重(男性 25-100 kg)、種族比較校正

檔案名: Swaa1r85b5.dfx

骨質密度影像

行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 骨質密度報告

受檢者:		病歷號:	
生日:	1972/6/ 49.3 歲	檢測ID:	X10AK6010
身高 / 體重:	170.0 cm 72.0 kg	測量:	2021/10/21 上午 (13.60)
性別 / 種族:	男性	分析:	2021/10/21 上午 (13.60)



骨質密度影像

精密儀器檢查 (**Precision instrument inspection**)

心胸血管分析組套

報告

心胸血管分析組套

診斷 (Diagnosis)

第一部分：全心冠狀動脈斷層攝影及鈣化分析

1. 全心冠狀動脈斷層攝影：左前降枝前段(S6)非鈣化性斑塊，造成輕度狹窄
2. 鈣化分析：指數為 0 分，在同年齡族群的百分比分佈為 0-25%，無偵測到斑塊，罹患冠心病風險非常低

第二部分：胸部腫瘤篩檢

右中肺葉及右下肺葉有輕度纖維性變化或次節葉塌陷
第三部分：其他發現
胸椎骨邊緣有輕度骨刺形成

報告全部 (Total)

第一部分：全心冠狀動脈斷層攝影及鈣化分析

攝影參數：Canon ACQUILION ONE genesis edition 探頭 0.5 mm，轉速 0.275 sec/周

檢查前用藥：() 無 (v) Inderal 20+20 mg

顯影劑：Non-ionic Low Osmolarity

注射速率：5 ml/sec，共 65 ml 心跳

速率：74-76 bpm

冠狀動脈分枝及命名：右冠狀動脈前段、中段、後段及右後降枝(S1,2,3,4)，左冠狀動脈主幹(S5)，左前降枝前段、中段、後段、第一分支、第二分枝(S6,7,8,9,10)，左迴旋枝前段、第一分支、中段、第二分枝、後段(S11,12,13,14,15)

1. 影像品質：

移動假影影響血管分析準確度 部位：S15

2. 鈣化指數 (Agatston score)：主幹: 0 前降枝: 0 迴旋枝:
0 右冠狀動脈: 0

心胸血管分析組套

右後降枝: 0

總分為 0 分，在同年齡族群的百分比分佈為 0-25%，無法偵測到斑塊，心血管疾病風險非常低。檢測結果陰性，罹患冠心病的危險度非常低。

3. 冠狀動脈顯要性

(v)右側顯要 (Right dominant)

()共同顯要 (Codominant)

()左側顯要 (Left dominant)

4. 冠狀動脈狹窄：右冠狀動脈前段、中段、後段及右後降枝(S1,2,3,4)：無冠狀動脈血管斑塊。

左冠狀動脈主幹(S5)：

無冠狀動脈血管斑塊。

左前降枝前段、中段、後段、第一分支、第二分枝(S6,7,8,9,10)：輕度 (<50%) 血管狹窄 位置：S6 斑塊種類 ()鈣化性 (v)非鈣化性 ()混合性左迴旋枝前段、第一分支、中段、第二分枝、後段(S11,12,13,14,15)：無冠狀動脈血管斑塊。

5. 先天性異常：無。

6. 其他：無

第二部分: 胸部腫瘤篩檢

肺 (Lung parenchyma)：

Mild fibrotic change or subsegmental atelectasis at RML and RLL. 右中肺葉及右下肺葉有輕度纖維性變化或次節葉塌陷。

肋膜 (Pleura)：無異狀氣道 (Airway)：無異狀縱

膈腔 (Mediastinum)：無異狀心臟及大血管

(Heart and great vessels)：無異狀淋巴 (Lymph

nodes)：無異狀

心胸血管分析組套

骨骼 (Bone) :

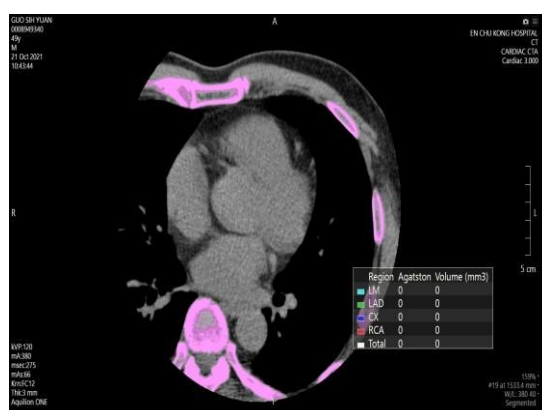
Mild marginal spur formation at thoracic spine.

胸椎骨邊緣有輕度骨刺形成。

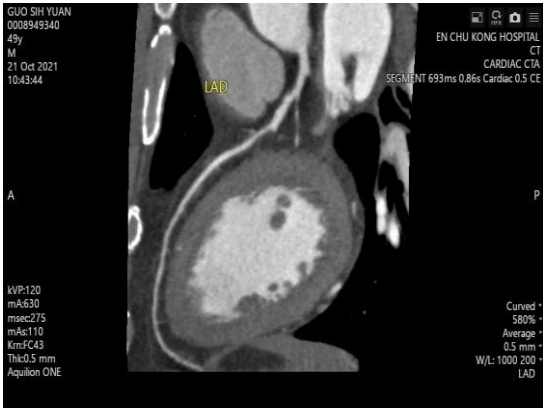
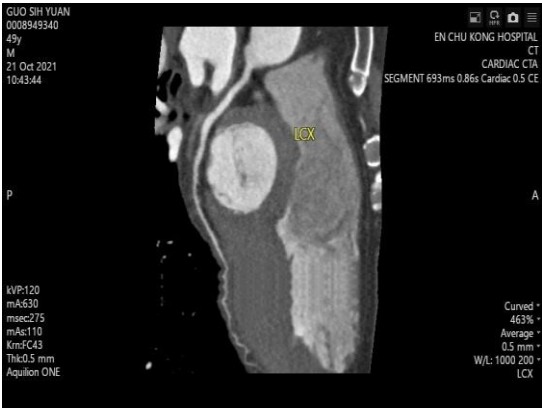
其他含部分上腹部 (Visualized upper abdomen) : 無異狀

請諮詢心臟專科醫師，與控制血壓、血糖與血脂肪等冠狀動脈心臟病之危險因子。此報告為影像診斷，其臨床意義需參考您的臨床表徵，請與您的臨床醫師討論。

電腦斷層影像



電腦斷層影像



核磁共振影像

全腦核磁造影

報告

診斷 (**Diagnosis**)

1. 腦實質無明顯異常
2. 右側椎動脈管腔較細小，疑屬先天性變異

報告全部 (**Total**)

Magnetic resonance imaging (MRI) of brain, without intravenous (IV) contrast administration showed:

- > Brain parenchyma: Unremarkable.
 - > Ventricular system and Sulci: Unremarkable.
 - > No midline shift.
 - > SDH, SAH, EDH: None.
 - > Visible paranasal sinuses and nasopharynx: Unremarkable.
 - > Bilateral mastoid air cells: Unremarkable.
 - > Dural venous sinuses and skull bone: Unremarkable.
 - > Bilateral internal auditory canals, bilateral middle and inner ears: Unremarkable.
 - > 3D-TOF MRA: Small right VA, suspicious hypoplasia.
1. Unremarkable finding of brain parenchyma.
 2. Small right VA, suspicious hypoplasia.

核磁共振影像

核磁共振影像

診斷 (Diagnosis)

1. 脂肪肝
2. 肝臟兩側有數顆疑似微小囊腫

報告全部 (Total)

Magnetic resonance imaging (MRI) of the abdomen, with and without intravenous (IV) contrast administration showed:

> Liver, portal system, & biliary ductal system:

- Fatty liver.
- Some tiny T2 hyperintense lesions in both lobes of liver, suspicious cysts.

> Spleen: unremarkable.

> Pancreas and pancreatic duct: unremarkable.

> Bilateral adrenal and kidneys: unremarkable.

> Para-aortic lymph nodes: unremarkable.

> Abdominal aorta, celiac trunk, splenic artery, SMA, and SMV: unremarkable.

> Gastrointestinal tracts: unremarkable.

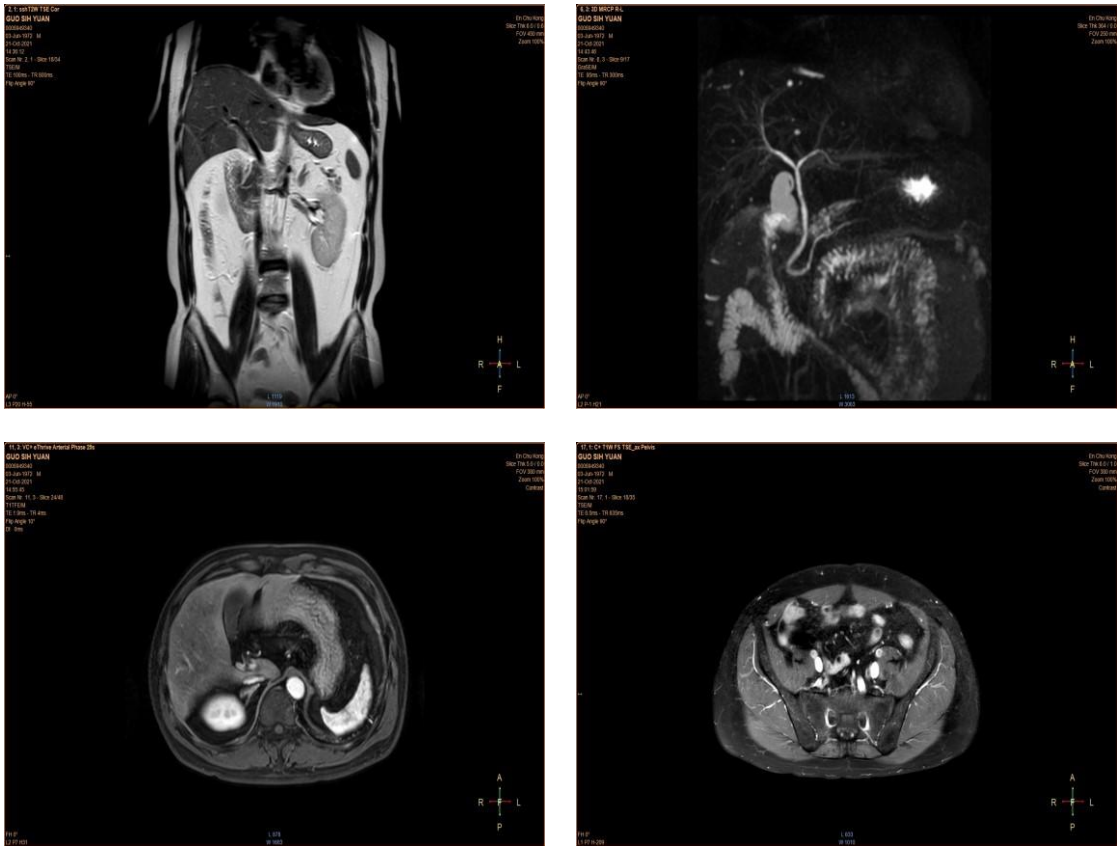
> Abdominal wall, ribs and spine: unremarkable.

1. Fatty liver.

2. Some tiny T2 hyperintense lesions in both lobes of liver, suspicious cysts.

核磁共振影像

核磁共振影像



全脊椎磁振造影(頸胸腰)

報告

核磁共振影像

診斷 (Diagnosis)

1. 頸椎第 5/6 節椎間盤退化造成椎管狹窄
2. 腰椎第 3/4 節及第 4/5 節椎間盤退化，未造成明顯椎管狹窄
3. 腰椎第 4 節及第 5 節終板呈現退化性變化

報告全部 (Total)

Magnetic resonance imaging (MRI) of whole spine without intravenous (IV) contrast administration showed:

- > Alignment of whole spine: n.p.
 - > Whole spine vertebrae, intervertebral discs, and spinal canal:
 - Degenerative disc at C5/6 causing spinal canal stenosis.
 - Degenerative disc at L3/4 and L4/5, without obvious spinal canal stenosis.
 - Degenerative change at L4 and L5 endplates.
 - > Paraspinal soft tissue: n.p.
1. Degenerative disc at C5/6 causing spinal canal stenosis.
 2. Degenerative disc at L3/4 and L4/5, without obvious spinal canal stenosis.
 3. Degenerative change at L4 and L5 endplates.

核磁共振影像

核磁共振影像